

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	憂鬱症 Depression				
編號	A31000-Q03-W-L01	制定者	PSY 李家靜	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.1 版/11 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解憂鬱症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

憂鬱症是一種以抑鬱為主的情緒障礙，持續性心情低落無法調適，影響到個人的認知、生理功能、及思想和行為的障礙，是屬於情感性精神疾病。

（二）症狀

憂鬱症狀經常伴隨其他精神疾病，如思覺失調、物質濫用、飲食障礙和邊緣性人格疾患，依據 DSM -5(2014)鬱症發作指出現以下至少五項（或更多）症狀，持續兩週，且需包含(1)抑鬱情緒或(2)對事物失去興趣或愉悅感任一項。

1. 身體層面：外表疲倦、無力及憔悴樣，忽略儀容外表、不修邊幅、個人衛生差。

症狀嚴重時，一個姿勢可維持許久不動，食慾的改變（明顯食慾變差或增加），有許多身體不適之抱怨（胸悶、心悸、腸胃不適、肌肉緊繃或酸痛、骨頭關節酸痛、頭痛、背痛、胸痛、頭暈），有便秘、尿滯留、月經停止或陽痿、性慾下降、睡眠障礙（幾乎每天失眠或嗜睡）等問題。

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/11

- 2.情緒層面：感到心情低落、時常想哭、悲觀、愁苦、無助、自責及自暴自棄或躁不安感，例如：自覺哀傷、不快樂，認為自己毫無價值、自尊心及自信心低落，將所有不如意歸罪於自己，罪惡感重，出現負向想法，反覆想到死亡。
- 3.智能層面：注意力、記憶力、判斷力減退，無法做決定，對週遭事物出現錯誤、消極的判斷。
- 4.思考層面：思考呈現貧乏、遲鈍或不連貫的型態；內容呈現悲觀、消極等意念，例如：出現無望感、自責、甚至有自殺意念。
- 5.社會與靈性層面：因為病人情緒抑鬱，活動少、少與人互動，多獨處或終日躺床，妨礙病人取得適當的社會支持與資源，進而影響病人的生活品質。

（三）常見治療

目前仍以生物治療包括（藥物治療、電痙攣治療）及心理治療為主，且因憂鬱症單次發作的再發率高達 50-60%，發作二次的再發率提高為 70%。發作三次的再發率更高達 90%，因此除以下之治療模式外，提供良好的支持系統也是很重要的。

1.藥物治療：

目前抗憂鬱藥物的第一線用藥以 SSRI 為主，這類藥物安全性高，副作用較少；第二線用藥是 venlafaxine(Efexor)、mirtazapine(Remeron)，各類藥物介紹如下：

- (1)選擇性血清素再吸收抑制劑(selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI)，這類藥物主要選擇性抑制血清素的再吸收。常見副作用：噁心、頭痛、顫抖、腸胃不適等。增加腦中的神經傳遞作用；常見的藥物有：fluoxetine(Prozac)、fluvoxamine(Luvox)、sertraline(Zoloft)、paroxetine(Seroxat)、citalopram 等。
- (2)血清素及正腎上腺素再吸收抑制劑(serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, SNRI)，屬二環抗鬱劑的一種，主要抑制正腎上腺素、血清素的再吸收，作為治療憂鬱症症狀。常見副作用：噁心、嗜睡、暈眩、盜汗、食慾不振及性功能障礙等。代表性藥物：venlafaxine(Efexor)。

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/11

(3)正腎上腺素及血清素拮抗劑(noradrenergic and specific serotonergic antidepressant, NASSA)，屬於四環類抗憂鬱劑，腎上腺素 α_2 接受體拮抗劑，促進正腎上腺素及血清素分泌。常見的藥物有：mirtazapine(Remeron)。

(4)其他新型抗鬱劑：主要抑制血清素神經末梢的血清素幫浦(5-HT pump)，以阻斷血清素再吸收；常見的藥物有：trazodone HCl(Mesyrel)。

(5)憂鬱症患者有精神病症狀者，可以合併低劑量的抗精神病藥物。

2.電氣痙攣法治療(electroconvulsive therapy, ECT)或重複經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)：若對藥物反應不佳，可考慮使用。

3.心理治療(psychotherapy)：目的是協助紓解壓力、情緒及克服壞習慣或解決人際關係的問題；以放鬆訓練、支持性心理治療、認知行為心理治療、解決問題導向之心理治療為主。

4.環境治療(milieu therapy)。

5.職能治療(occupational therapy)。

(四) 護理問題

- 1.自我傷害或暴力／抑鬱。
- 2.缺乏營養／抑鬱（沮喪）。
- 3.排便異常：便秘／腸胃活動減弱。
- 4.睡眠障礙／焦慮反應。
- 5.自我照顧尋求協助穿著/修飾／抑鬱。
- 6.失去因應能力／對自己有過度負向的看法、無助。
- 7.長期性低自尊／長期負面、定型的生活反應。

(五) 護理措施

- 1.自我傷害或暴力／抑鬱

(1)提供治療性且安全的環境，色調宜明亮、勿吵雜，入院時及每班或不定時安檢。告知訪客帶入的物品須安檢，進入病房前須移除隨身危險物品並放置於門外置物櫃，如尖銳物品、玻璃製品、金屬製品、繩子等。

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/11

- (2)將病人置於人多的房間或近護理站，必要時需隨時有人陪伴，可聯絡病人的家屬或其親近的人來院協助或請看護 24 小時照顧。
- (3)引導病人察覺自身情緒狀態，當有不適切及自殺意念出現時，主動尋求護理人員協助。
- (4)觀察與記錄病人言行、動態及自傷行為的先兆（尤其以憂鬱症恢復期之初期 3 至 6 個月），特別是在夜班、假日及交班時段，須特別的注意。
- (5)觀察並執行藥物確實服下，以防藏藥及儲藥。
- (6)採主動關心方式，建立治療性人際關係定時個別會談，傾聽病人的感受與心聲，鼓勵表達感受，不要給予個人的意見或批判，隨時評估病人的自殺意念強度、是否有自殺計畫等，並密切觀察之。
- (7)衛教以健康、不傷害自己的方式發洩或放鬆情緒（例如：打枕頭、扭毛巾、撕紙條、提供保護室、大哭、聽音樂、運動等）。
- (8)醫療團隊共同討論病人情況及處理方式，醫師以藥物協助或必要時給予隔離或約束保護。
- (9)提供出院後可利用的資源，如：醫院自殺防治專線、生命線，出院後持續追蹤。

2. 缺乏營養／抑鬱（沮喪）

- (1)了解食慾下降或拒食原因，協助澄清解釋並鼓勵進食。
- (2)以少量多餐方式供餐，隨時給予提供飲料與點心，並給予充足時間進食，必要時請家屬幫忙病人準備喜愛的食物或協助餵食。
- (3)選擇易消化及咀嚼之高熱量、高蛋白及高維生素食物。
- (4)觀察進食情形必要時記錄飲食狀況及評估實際營養需求及體重的變化，提醒飲水，以防止脫水。

3. 排便異常：便秘／腸胃活動減弱

- (1)鼓勵多攝取高纖維素食物，如：穀類食品、麵包、水果、蔬菜、果仁和種子等，要注意當在增加食用高纖維食物的同時，也須增加水份或流質的攝取量

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/11

(每天應飲用約 1500-2000cc)，以免便秘加劇。

(2)經常運動是其中一種可以預防及治療便秘的方法，故宜鼓勵病人多參與活動，

增加適合體能的運動如跑步、步行等，都可以幫助預防及治療便秘。

(3)排便訓練：習慣餐後上廁所、每天定時上廁所（例如在早上）、使用合適高

度的便器（如：馬桶、便盆椅），雙腳平放在地面或小凳子上，身體微微向

前傾以放鬆盆腔肌肉，可免排便過程太過用力。

(4)超過 3 天未排便或有不舒服之主訴時，可依醫囑給藥（MgO、Dulcolax、

Sennapur 等）或灌腸。

4. 睡眠障礙／焦慮反應

(1)了解過去及近日之睡眠形態及作息時間，每 30 分觀察並記錄睡眠型態，監

測影響睡眠的因素（例如焦慮、擔憂或疼痛）。

(2)白天盡量減少躺床機會或時間，包含白天的午休、小睡片刻或打瞌睡都應避

免，鼓勵多下床活動或協助安排活動參與，以免影響夜眠。

(3)提供睡眠衛生教育，建立良好睡眠習慣及品質。

(4)為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料。

(5)睡前可做溫和及放鬆身心之活動，如：肌肉鬆弛及呼吸運動（吐納）。

(6)觀察走路步態避免跌倒，必要時給予帶領（扶持）至單位，協助躺床，若拒

絕回房，但仍呈倦怠狀，則請醫佐協助必要時暫約束於床上，熟睡後再解除

約束，過程需向病人說明。

(7)若於半夜醒來，鼓勵病人再回房入睡；若主訴已睡飽，在不干擾病房安寧下，

允許病人做私人的事，如看報、靜坐等。

(8)當有入睡困難（服完睡前藥後 2 小時仍未能入睡）或睡眠中斷再入睡困難時

（夜醒 1 小時仍未能再入睡），可連絡值班醫師評估依醫囑給藥。

(9)與醫師討論藥物之調整。

5. 自我照顧尋求協助：穿著／修飾／抑鬱

(1)與病人討論以評估個人衛生執行狀況，依個別性約定沐浴執行時間。

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/11

- (2)協助將日常個人衛生用品簡化並放置固定位置，以方便取用，於沐浴時間提醒病人自行或協助準備沐浴用品。
- (3)初期要耐心引導、協助或督促完成盥洗、沐浴、更換乾淨衣褲；評估其執行能力，如需完全協助時：男病人：請男性護理人員或醫佐協助沐浴（護理人員請協助準備用品）；女病人：由女性護理人員協助，；需半協助時，於沐浴時間提醒病人並與其一同準備用物，於浴室觀察其執行情形。
- (4)鼓勵病人在能力範圍內盡可能自行執行衛生活動；完成沐浴時帶病人至鏡前鼓勵注意外觀及儀容整理（女則注意頭髮清潔、梳理，男則需注意刮鬍子）等。
- (5)當病人有能力獨立執行時，給予足夠的時間使病人在無人的協助下盡其最大的能力完成。
- (6)以漸進式方式讓病人學習獨立完成盥洗、沐浴及儀容整理，增加病人對自己的重視與興趣。
- (7)對於病人儀表改變之進步，須具體將改變之處指出並給予口頭的鼓勵與肯定。

6.失去因應能力／對自己有過度負向的看法、無助

- (1)增進病人對疾病的認知，利用會談機會進行衛教，以了解憂鬱症症狀，並給予相關藥物之衛教。
- (2)以和善、真誠、支持、耐心 and 了解的態度協助病人，使之感受到自己是被接受的。
- (3)會談過程應鼓勵並協助病人談論其想法和感覺，使之感受到被尊重並學習自我表達；當出現不合理信念時，應予澄清觀念，以防因個人連續的挫敗經驗，而致想法偏差，肯定其優點與過去成就，明白指出進步之處，增加對自我的了解，以提昇自我價值。
- (4)和病人討論身邊可利用的資源，鼓勵主動尋求協助，如找信賴的親友、醫護人員、心理師、張老師進行討論諮詢等。
- (5)鼓勵抒發情感，協助病人學習以健康方式發洩其情緒，如：肌肉放鬆、聽音

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/11

樂、看電視或大叫、寫日記、找人傾訴或捶打棉被等；當病人表達憤怒時，採接受態度並鼓勵發洩。

7.長期性低自尊／長期負面、定型的生活反應

- (1)發展良好信任的護病關係，以支持性的角色陪伴與鼓勵病人，使病人察覺自己的重要與價值。
- (2)以漸進式方式來安排病人的活動，先是以簡單、容易完成，不具競爭性、不消耗體力或服務性質的活動為主，漸進地由被動轉為主動式的團體活動，以增加自信心，如先陪伴散步，手工藝活動或協助病室餐桌之清潔，再安排種花等園藝工作。病人持負向看法時，以接納的態度傾聽，可以具體、明確地證據來肯定其優點、長處與成就。
- (3)當病人有進步行為或想法時，鼓勵自我肯定，並以口頭讚美或正向回饋。
- (4)增加人際互動的機會，鼓勵參加職能活動或大廳活動，參與團體活動時引導病人表達想法與感受，給予正向評價，提升自尊心。
- (5)讓病人參與治療計畫，重視其感受，增加自我控制感。
- (6)與病人討論其對疾病的感受與想法，協助澄清病人對疾病的錯誤認知，增加其對疾病與藥物的正確認知，讓病人知道疾病是可以被控制的。
- (7)增進家屬對疾病及藥物的正確認知，加強對家屬的心理支持，學習新的處理技巧，以幫助病人重新適應並回歸社區。
- (8)建立適當的生活型態，並檢視自我價值，協助病人看見自己的優點，並教導自我認同之技巧。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/11

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林式穀(2019)·精神藥物手冊(第三版)·台北市：合記圖書出版社。
- (二) 王純娟、劉玉雲、戎謹如、黃瑞媛、廖肇安、劉玟宜...陳妙絹(2019)·肌體治療·於蕭淑貞總校閱，精神科護理概論(十版，189-240頁)·台北市：華杏。
- (三) 何美欣、蔡瑞修、董俊良(2025)·重複經顱磁刺激在憂鬱症治療中的應用與進展及與傳統治療的比較·臨床醫學，1-12。
- (四) 陳春蘭、曾錦花、蕭妃秀(2021)·雙相情緒障礙症及憂鬱症之護理·於蕭淑貞總校閱，精神科護理學(十版，430-464頁)·台北市：華杏。
- (五) American Psychological Association. (2014)·DSM-5精神疾病診斷準則手冊(臺灣精神醫學會譯)·台北市：合記圖書出版社。(原著出版於2013)

七、附件

(略)

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.修改說明及文獻內容 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容有部份修訂	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	1. 說明內容修正錯別字及標點符號 2. 參考資料文獻部份內容更新	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.3	1. 第三項第（二）目之 5 及第（三）目之 3 新增部份內容。 2. 第六項參考資料部份刪修及修訂 APA 格式。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.4	1. 第三項第（二）部份內容新增。 2. 參考文獻新增於內文。 3. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.5	1. 第三項第（二）、第（三）目部分內容修訂。 2. 第六項參考資料文獻部份增刪。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一、二、三目說明內容修訂。 3. 第三項第五目之 1、2、3、6、7 說明內容修訂。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	10/11

修正日期	版本	修正說明	備註
		4. 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 第六項參考資料文獻部份增刪。	通過公布。
109.08.18	3.7	1. 修正第三項第三目參考資料。 2. 第六項參考資料部份增刪。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.8	1. 第三項第一、二、三目之說明內容修訂。 2. 第三項第四、五目護理問題修正。 3. 第六項參考資料文獻部份增刪及更新。 4. 內文參考文獻統一刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.9	第六項參考資料部份刪除。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	4.0	1. 第三項第五目之 1.(1)、(4)說明內容文字修訂。 2. 第六項參考資料部份刪除。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.1	1. 第三項第三目之 2 說明內容修訂。 2. 第六項參考資料文獻部份增刪。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	憂鬱症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註